



Resifriends
By Fátima Barbosa

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · CONTEÚDO BÔNUS

Epidemiologia e Educação em Saúde

Indicadores de saúde · Notificação compulsória · Vigilância
Educação em saúde e promoção

★ BÔNUS DA TURMA · QUESTÕES COMENTADAS

Profa. Fátima Barbosa

Lista de notificação conferida · Portaria GM/MS nº 11.211/2026

Por que este bônus existe

Este conteúdo não faz parte das nossas aulas ao vivo — mas cai na prova. Então ele vai aqui, de presente, para você não deixar ponto na mesa.

São dois temas que se conectam: a **epidemiologia** mede a saúde da população, e a **educação em saúde** é o que transforma esse conhecimento em mudança. Ambos são atribuição direta da enfermagem.

O MAPA DESTE BÔNUS

- ◆ **Indicadores de saúde** — os coeficientes que a prova cobra com fórmula.
- ◆ **Notificação compulsória** — o que notificar, quando e para quem.
- ◆ **Vigilância em saúde** — os quatro tipos.
- ◆ **Educação em saúde** — o modelo que a banca considera correto.

Nota de atualização

A Lista Nacional de Notificação Compulsória é alterada **com frequência** — houve mudanças em 2023, 2024, 2025 e duas em 2026. Este material segue a **Portaria GM/MS nº 11.211, de 13 de maio de 2026**. Confirme a versão vigente antes da prova.

Sumário

1 Indicadores de saúde

Conceitos básicos

Mortalidade

Morbidade

Natalidade

2 Notificação compulsória

Quem, quando e como

Imediata × semanal

As atualizações de 2026

3 Vigilância em saúde

Os quatro tipos

Investigação de surto

4 Educação em saúde

Modelos

Promoção da saúde

5 Síntese e bizzos finais

Revisão rápida

1

Indicadores de saúde

Números que descrevem uma população. Aqui a prova cobra fórmula.

1 · Os conceitos que organizam tudo

Antes das fórmulas, três pares de conceitos. Errar aqui é errar todas as questões seguintes.

TERMO	DEFINIÇÃO
Incidência	Casos NOVOS em um período. Mede o risco de adoecer.
Prevalência	Casos EXISTENTES (novos + antigos) em um momento. Mede a carga da doença.
Endemia	Ocorrência habitual e esperada de uma doença numa região.
Epidemia	Ocorrência acima do esperado , em uma região.
Pandemia	Epidemia que atinge vários continentes .
Surto	Epidemia restrita a um espaço delimitado (uma creche, um bairro, um hospital).

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A relação entre incidência e prevalência resolve muita questão. Pense numa banheira: a **incidência é a torneira** (casos entrando); a **prevalência é a água acumulada**; a cura e o óbito são o **ralo**.

Consequências: uma doença **crônica** (tuberculose, hanseníase, HIV) tem **prevalência alta** mesmo com incidência baixa — a água fica na banheira. Uma doença **aguda e letal** (raiva) tem prevalência baixíssima mesmo com surto — o ralo é rápido. E, contraintuitivamente: *um tratamento que não cura mas evita a morte AUMENTA a prevalência*, porque fecha o ralo sem fechar a torneira.

PEGADINHA CLÁSSICA

Se a banca disser que um novo tratamento “reduziu a prevalência” porque mantém os pacientes vivos — está **errado**: ele **aumenta** a prevalência. Só reduz prevalência o que *cura* ou o que *previne* (reduz incidência).

1 · Indicadores de mortalidade

São os mais cobrados. Guarde o **numerador**, o **denominador** e a **base** (por quantos).

INDICADOR	CÁLCULO
Mortalidade infantil	Óbitos de menores de 1 ano ÷ nascidos vivos × 1.000 . É o indicador mais sensível das condições de vida.
— Neonatal precoce	0 a 6 dias de vida.
— Neonatal tardio	7 a 27 dias.
— Pós-neonatal (infantil tardio)	28 dias a menos de 1 ano.
Mortalidade materna	Óbitos maternos ÷ nascidos vivos × 100.000 . Até 42 dias após o fim da gestação, por causa ligada à gravidez.
Mortalidade geral	Total de óbitos ÷ população × 1.000.
Letalidade	Óbitos pela doença ÷ casos da doença × 100. Mede a gravidade .

BIZU ESTRATÉGICO

A troca campeã: **mortalidade** × **letalidade**. O denominador entrega a resposta — **mortalidade** tem no denominador a **população** (quantos morreram entre todos); **letalidade** tem os **doentes** (dos que adoeceram, quantos morreram). Mortalidade = risco na população; letalidade = gravidade da doença.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que a **mortalidade infantil** é o retrato das condições de vida — e por que sua *composição* importa mais que o número: o componente **pós-neonatal** (28 dias a 1 ano) está ligado a fatores **ambientais e sociais** — saneamento, nutrição, acesso. O componente **neonatal** (0-27 dias) depende mais de **assistência ao pré-natal e ao parto**.

Então: quando um país melhora saneamento, cai primeiro o pós-neonatal. Quando a mortalidade infantil já é baixa e o que sobra é *neonatal*, o gargalo passou a ser a **qualidade da assistência** — que é o caso do Brasil hoje.

INDICADOR	INTERPRETAÇÃO
Razão de mortalidade proporcional (Indicador de Swaroop-Uemura)	Proporção de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais em relação ao total de óbitos. Quanto MAIOR, MELHOR o nível de saúde.
Curva de Nelson de Moraes	Curva de mortalidade proporcional por faixa etária. Tipos: I (muito baixo), II (baixo), III (regular), IV (elevado nível de saúde).

PEGADINHA CLÁSSICA

Swaroop-Uemura: quanto maior, melhor. É contraintuitivo — parece que “mais óbitos” é ruim, mas o indicador mede a *proporção* de quem morre **com 50 anos ou mais**. Se a maioria dos óbitos é de idosos, significa que as pessoas estão **chegando lá**. Nível I = pior; nível IV = melhor.

1 · Morbidade e natalidade

INDICADOR	CÁLCULO
Coeficiente de incidência	Casos novos ÷ população exposta × base.
Coeficiente de prevalência	Casos existentes ÷ população × base.
Taxa de natalidade	Nascidos vivos ÷ população × 1.000.
Taxa de fecundidade	Nascidos vivos ÷ mulheres em idade fértil (15–49 anos) × 1.000.

◆ Sistemas de informação

SISTEMA	O QUE REGISTRA
SINAN	Agravos de notificação.
SIM	Mortalidade — alimentado pela Declaração de Óbito (DO).
SINASC	Nascidos vivos — alimentado pela Declaração de Nascido Vivo (DNV).
SI-PNI	Imunizações.
SISAB / e-SUS APS	Atenção básica.

BIZU ESTRATÉGICO

Guarde pelo nome: **SIM** = mortalidade (“morte”); **SINASC** = nascidos vivos; **SINAN** = agravos de notificação. Os indicadores infantil e materno cruzam **$SIM \div SINASC$** — óbitos sobre nascidos vivos.

2

Notificação compulsória

A lista muda todo ano — e é justamente por isso que ela cai.

2 · Quem, quando e como

Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017 · atualizada pela Portaria GM/MS nº 11.211, de 13/05/2026

ITEM	REGRA
Quem notifica	Todo profissional de saúde e responsáveis por estabelecimentos públicos E privados.
O que se notifica	Em regra, o caso suspeito ou confirmado — não se espera o laudo.
Instrumento	SINAN (ficha de notificação).
Notificação imediata	Até 24 horas. Para SMS, SES e/ou MS, conforme o agravo.
Notificação semanal	Até 7 dias. Em regra, para a SMS.
Sigilo	A notificação é sigilosa. Não notificar pode configurar negligência.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A lógica que define **imediata** × **semanal**: notifica-se em 24h aquilo cuja demora custa vidas ou permite explosão — doenças de **alta transmissibilidade**, **graves**, **raras** ou **eliminadas do país** (cuja re-ocorrência é emergência). Notifica-se semanalmente o que é comum, crônico ou de evolução lenta — onde 7 dias não mudam a resposta.

Aplicando: **sarampo** (quase eliminado + altamente transmissível) = imediata. **Tuberculose** (comum, crônica) = semanal. A pergunta que responde qualquer questão é: “se eu esperar uma semana, o estrago cresce muito?”

PERIODICIDADE	AGRAVOS
Exemplos de IMEDIATA (24h)	Sarampo, raiva humana, botulismo, cólera, febre amarela, poliomielite, violência sexual, tentativa de suicídio, óbito por dengue/zika/chikungunya, eventos de saúde pública, parotidite (caxumba), difteria, tétano.
Exemplos de SEMANAL (7 dias)	Tuberculose, hanseníase, sífilis, HIV/aids, hepatites virais, dengue (casos), leishmanioses, esporotricose, anomalias congênitas, doença falciforme, febre do Oropouche (casos).

PEGADINHA CLÁSSICA

Exceção que cai: em regra notifica-se a **suspeita** — mas alguns agravos só são notificados após a **confirmação**, porque o quadro inicial é inespecífico demais: **tuberculose, sífilis, HIV/aids, hepatites virais, HTLV, doença de Chagas crônica**. Se toda tosse fosse notificada como TB, o sistema colapsaria.

2 · As atualizações de 2026

Este é o conteúdo mais recente do eixo — e o que material antigo nem menciona.

O QUE MUDOU (PORTARIA GM/MS Nº 11.211, DE 13/05/2026)

- ◆ **Parotidite (caxumba)** — **incluída** na lista, com notificação **IMEDIATA** (SMS, SES e MS).
- ◆ **Febre do Oropouche** — **incluída**: casos com notificação **semanal**; **imediata** em óbitos, óbitos fetais, gestantes e anomalias congênitas.
- ◆ **Difteria** — passou a exigir notificação **imediata ao Ministério da Saúde**.
- ◆ **Tétano** (acidental e neonatal) — passou a exigir notificação **imediata às SES**; o neonatal também ao MS.
- ◆ **Covid-19** — **deixou de ser item isolado**; passa a integrar “Síndrome Gripal por covid-19 confirmada”.
- ◆ **ESAVI** — o termo “eventos adversos pós-vacinação” passa a ser **Evento Supostamente Atribuível à Vacinação ou Imunização**.
- ◆ **Vigilância sentinela**: entrou a **Doença Invasiva por Haemophilus influenzae**; saiu a **SRAG**.

BIZU ESTRATÉGICO

Se a sua apostila traz **covid-19 como item isolado** da lista, ou **não menciona caxumba e Oropouche**, ela é anterior a maio de 2026. E atenção à sequência recente: 2023 (doença falciforme), 2024 (HTLV e doenças do trabalho), 2025 (esporotricose), janeiro/2026 (anomalias congênitas), maio/2026 (caxumba e Oropouche). A lista muda **todo ano**.

3

Vigilância em saúde

Quatro olhares sobre o mesmo problema.

3 · Os quatro tipos

TIPO	OBJETO
Epidemiológica	Doenças e agravos: detecção, investigação, controle. É a que usa o SINAN.
Sanitária	Riscos de produtos, serviços e ambientes. Ex.: fiscalização de restaurante, medicamentos, serviços de saúde. É a ANVISA e as vigilâncias locais.
Ambiental	Fatores do meio ambiente que afetam a saúde: água, ar, solo, vetores, desastres.
Saúde do trabalhador	Agravos relacionados ao trabalho . Ex.: acidente de trabalho, LER/DORT.

BIZU ESTRATÉGICO

Diferencie pelo **objeto**: **Epidemiológica** = a *doença*. **Sanitária** = o *produto/serviço* (fiscalização). **Ambiental** = o *meio*. **Trabalhador** = o *trabalho*. Fiscalizar a validade do alimento é **sanitária**; investigar quem passou mal comendo é **epidemiológica**.

◆ Investigação de surto

BIZU ESTRATÉGICO

Definições que caem: **caso índice** = o primeiro caso *identificado* pelo serviço. **Caso primário** = o que *introduziu* a doença no grupo. **Caso secundário** = os que adoeceram a partir do primário. Nem sempre o caso índice é o primário — e é aí que a banca pega.

4

Educação em saúde

Não é palestra. É diálogo — e a banca sabe disso.

4 · Os dois modelos

MODELO	CARACTERÍSTICA
Tradicional / bancário	O profissional deposita informação; o usuário recebe passivamente. Foco na doença, na culpabilização e na prescrição de comportamentos. Modelo criticado.
Dialógico / problematizador	Constrói o saber com o usuário, valorizando o conhecimento prévio e o contexto. Foco na autonomia e no protagonismo. Modelo preconizado.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

Por que o modelo tradicional **não funciona** — e a prova cobra isso: dizer a uma pessoa “pare de comer sal” pressupõe que ela não sabe. Mas ela sabe. O que falta não é *informação* — é **condição**, contexto, sentido. Por isso a educação dialógica parte do que a pessoa já sabe e vive, e constrói junto uma saída possível.

A consequência prática: **culpabilizar o usuário** (“não se cuida”, “não adere”) é o erro central. A não adesão quase sempre tem uma *razão* — e descobri-la é trabalho da enfermagem.

PEGADINHA CLÁSSICA

Alternativa com verbos de **imposição** — “orientar que o paciente *deve*”, “instruir”, “alertar sobre os riscos para que mude o comportamento”, palestra unidirecional — costuma ser a **errada**. A correta traz **escuta, diálogo, valorização do saber popular, roda de conversa, construção compartilhada e autonomia**.

◆ Promoção da saúde

CONCEITO	FOCO
Prevenção	Foco na doença : evitar que ela ocorra ou progrida.
Promoção	Foco na saúde e nos determinantes : qualidade de vida, condições de moradia, trabalho, educação, ambiente.

BIZU ESTRATÉGICO

Níveis de prevenção (Leavell & Clark): **primária** = evitar a doença (vacina, educação); **secundária** = diagnóstico precoce (rastreamento, Papanicolau); **terciária** = reabilitação, evitar sequelas. Alguns autores somam a **quaternária** = evitar **iatrogenia** e intervenção desnecessária.

APROFUNDAMENTO CLÍNICO

A diferença entre **promoção** e **prevenção primária** é sutil e cai: a *prevenção primária* mira uma **doença específica** (vacinar contra sarampo evita sarampo). A *promoção* mira os **determinantes** — saneamento, renda, educação — e melhora a saúde **em geral**, sem alvo único. Promoção é mais ampla que prevenção.

5

Síntese

Os números e as trocas que decidem.

5 · Revisão rápida do bônus

INDICADORES

- ◆ **Incidência** = casos novos (risco). **Prevalência** = casos existentes (carga). Banheira: torneira × água acumulada.
- ◆ Tratamento que evita morte sem curar **umenta** a prevalência.
- ◆ **Mortalidade**: denominador = população. **Letalidade**: denominador = doentes.
- ◆ Mortalidade infantil: óbitos < 1 ano ÷ nascidos vivos × **1.000**. Materna: × **100.000**, até **42 dias**.
- ◆ Neonatal precoce **0-6d** · tardio **7-27d** · pós-neonatal **28d-1 ano**.
- ◆ **Swaroop-Uemura**: quanto maior, melhor (óbitos ≥ 50 anos / total).
- ◆ **SIM** = óbito · **SINASC** = nascido vivo · **SINAN** = notificação.

NOTIFICAÇÃO, VIGILÂNCIA E EDUCAÇÃO

- ◆ Notifica-se a **suspeita**, em serviço **público e privado**. Sigilosa.
- ◆ **Imediata (24h)**: grave, raro, altamente transmissível ou eliminado. **Semanal (7d)**: comum e crônico.
- ◆ Só na **confirmação**: TB, sífilis, HIV, hepatites, HTLV, Chagas crônica.
- ◆ **2026**: entraram **caxumba (imediata)** e **Oropouche**; **covid saiu** como item isolado; difteria e tétano viraram imediata.
- ◆ Vigilância: epidemiológica (doença) · sanitária (produto) · ambiental (meio) · trabalhador.
- ◆ Educação em saúde: modelo **dialógico**, não bancário. **Não culpabilizar**.
- ◆ Prevenção: primária (evitar) · secundária (diagnóstico precoce) · terciária (reabilitar) · quaternária (evitar iatrogenia).

PEGADINHA CLÁSSICA

As trocas campeãs: (1) inverter mortalidade e letalidade (olhe o denominador); (2) achar que Swaroop-Uemura alto é ruim; (3) dizer que tratamento que prolonga vida reduz prevalência; (4) usar lista de notificação desatualizada (sem caxumba/Oropouche, com covid isolada); (5) marcar alternativa de educação em saúde com verbo de imposição. Domine essas cinco e o bônus é ponto certo.

“Este conteúdo é o meu presente para você. Não deixe ponto na mesa por causa do que não foi dado em aula.”

RESIFRIENDS · BIBLIOTECA DE ESTUDO · BÔNUS

Conteúdo conferido nas fontes oficiais: Portaria de Consolidação GM/MS nº 4/2017, atualizada pelas Portarias GM/MS nº 10.175, de 23/01/2026, e nº 11.211, de 13/05/2026; sistemas de informação do DATASUS. A Lista Nacional de Notificação Compulsória é alterada com frequência — **confirme a versão vigente antes da prova.**